

• 药物与临床 •

药物相互作用(续表)

二、抗寄生虫病药	处 理
氯喹(C) - 肌松药(包括氨基糖苷、安定类等):本品有神经肌肉阻滞作用,可加重肌松作用,乃至出现意外。 - 洋地黄类:对已洋地黄化患者,本品可抑制心脏传导。 - 肝毒性药物:肝毒性加重。 - 肝素:增加出血机会(青霉素与C合用也有此反应)。 奎宁(Q) - 制酸药:减少奎宁的口服吸收。 - 抗凝作用增强。 - 肌松作用加强,可致意外。 - 硝苯地平:Q的游离血浓度提高。 哌嗪(P):枸橼酸哌嗪、磷酸哌嗪。 - 氯丙嗪:可能引起抽搐。 - 噻啉啉:拮抗、作用减弱。	禁止联用 监测心功能 监测凝血功能 避免服用 监测凝血功能 禁止联用 避免联用 禁忌
三、麻醉药及麻醉辅助药	处 理
吸入麻醉药 - 肌松药(包括氨基糖苷、安定类、奎宁等):肌松作用加强,可致意外。联用的非去极化肌松药,剂量应减少1/3。 - 抗高血压药:降压作用加剧。 - 儿茶酚胺类:可致心律失常。 硫喷妥钠(T) - 降压药(各种类型):降压作用加强 - 硫酸镁:中枢抑制加深。 氯胺酮(K) - 甲状腺素:可能引起血压升高或心动过速 依托咪酯(E) - 肾上腺皮质激素:E可抑制激素的体内合成,产生肾上腺功能不足症状,出现水盐代谢紊乱,低血压、甚至休克。 普鲁泊福(P) - 安定类:动物实验,合用延长睡眠时间。 - 阿片类:呼吸抑制加强。 局麻药 - 具有对氨基苯甲酸结构的药物(磺胺类):受普鲁卡因类的影响而降效。 - 中枢抑制药:多数的局麻药均可增强中枢抑制作用。 - 影响心功能的药物:许多局麻药可影响心功能,布比卡因有较强的心脏毒性,尤应注意。 肌松药	十分谨慎或禁忌 慎用 谨慎 应将降压药减至最低维持量但 不要停药,并加强观察 谨慎 应十分注意,必需时补充激素 注意 注意 禁忌 谨慎 十分谨慎

• 其他肌松药物(氨基糖苷、林可霉素类、多粘菌素类、安定类、氯唑沙宗)以及含枸橼酸钠的库存血、镁盐等:肌松作用加强,可致意外。 • 阿片类、吸入麻醉药、受体阻滞药、局麻药等:肌松作用加强,可致中枢、呼吸抑制。 • 强心苷类:作用加强或改变,可致心律失常。 • 锂盐:可使琥珀胆碱、泮库溴铵、阿曲库铵时效增强。 • 钙盐:肌松作用减弱。 • 肾上腺皮质激素、排钾利尿药、两性霉素 B:血钾下降可使非去极化肌松药明显增效,必需应用时应补钾。	十分谨慎,禁用 十分谨慎 十分谨慎 十分谨慎 临床监测血钾和观察
抗胆碱酯酶药 • 酰胺类局麻药(利多卡因、布比卡因等):麻药的水解受阻、易致中毒(酯类局麻药也可有类似相互作用)。 • 阿托品及其他抗 M 胆碱药(奎尼丁、普鲁卡因胺等):抗胆碱酯酶药的作用减弱,影响重症肌无力的治疗。	禁用或慎用 避免联用

滥用抗生素现状与对策

葛建国

目前我国滥用抗生素的现象十分普遍,长期滥用抗生素引发日益严重和广泛的细菌耐药,尤其是多重耐药菌株大量出现。据统计,常见致病菌的耐药率已达 30%~50%,且以每年 5% 的速度增长,控制滥用抗生素已刻不容缓。

1 滥用抗生素现状

1.1 不明原因的发热滥用抗生素 感染经常伴有发热,但发热不一定是感染。不明原因的发热滥用抗生素,可引起药物不良反应,且干扰疾病的正确诊断。

1.2 病毒感染滥用抗生素 上呼吸道感染 90% 以上为病毒感染,抗生素对病毒无效。目前一种十分不良的倾向是凡上呼吸道感染都给予抗生素,包括流行性腮腺炎、水痘、带状疱疹也普遍应用抗生素治疗。

1.3 无适应证应用抗生素 感冒后咳嗽迁延不愈,可能是由于气道反应性增高等原因所致,往往长时间应用多种抗生素仍无效,支气管哮喘发作诱因不都是细菌感染,病人往往常规应用抗生素。应用抗生素的指征应是发热、白细胞增高和黄脓痰,没有指征不能应用抗生素。

1.4 预防性应用抗生素过滥 心力衰竭、休克、肾病综合征、血液病等普遍预防性应用抗生素,以上疾病预防用药并无效果,反而可能引起耐药菌感染。

1.5 选用抗生素求新、求贵、求广谱 有些临床医生错误地认为,抗生素愈新、价格愈贵、抗菌谱愈广疗效愈好,选用抗生素求新、求贵、求广谱。这种用药方法忽略了新、老各类抗生素的作用特点及同类而不同品种抗生素之间的差别。以头孢菌素类为例,对于革兰阴性杆菌,特别是产酶耐药阴性杆菌引起的重症感染,头孢菌素是愈新愈好,第三代头孢菌素的抗菌作用明显超过第二代和第一代;但对耐药金黄色葡萄球菌引起的感染,第三代头孢菌素的疗效却不及第一代和第二代。因此不是任何情况下,新

品种抗生素都优于老品种。不加选择地将第三代头孢菌素作为常用抗生素应用,必然会诱导产生对多种第三代头孢菌素交叉耐药的细菌。一旦这种耐药菌引起严重感染,则病情难以控制。故临床医生若选用广谱抗生素偏多而依据很不充分,不仅杀伤非致病菌,且可使细菌为了适应环境而产生的耐药性迅速蔓延。

1.6 无指征联用抗生素 当前无指征联用抗生素的情况十分普遍,不合理的联合用药不仅不增加疗效,反而降低疗效,容易发生二重感染,增加不良反应及增加耐药性细菌产生的机会。

1.7 经验治疗太多 临床医生使用抗生素前送检相应标本做微生物检查过少,采标本检查的不到应用抗生素的 1/10。国内许多医疗单位细菌培养和药敏试验严重滞后于临床,加之临床取样不能按常规操作,结果不准确,使其不能给临床准确提供病原学依据,医生使用抗生素只能凭经验试探性用药。

2 控制抗生素滥用对策

2.1 建立抗生素管理制度 卫生行政部门应制定抗生素用药规范和抗生素应用指南。我国目前已制定出肺部感染的抗生素应用指南,医院应设抗生素管理机构,把好处方权分配关。将抗生素分为三线:一线(各类感染性疾病的首选药物)、二线(适当限制药物)、三线(严格限制药物)。并对处方权加以划分,医师有一线抗生素处方权,主治医师有一、二线抗生素处方权,副主任医师、主任医师有一、二、三线抗生素处方权。根据细菌耐药动态和发展趋势,有计划地将抗生素分批、分期交替使用。

2.2 本地区致病菌耐药性监测 由于各地区用药种类的不同,细菌的耐药性也存在较大的差别。监测本地区致病菌的耐药状况,能准确反映耐药菌活动情况,有效地为医生提供本地区致病菌耐药性的参数。

2.3 加强抗生素使用教育 各医疗单位对各科医生、护士和药房工作人员应进行广泛、持久的抗生素临床药理知识的再教育,通过岗前培训、定期讲课和考核,不断提高正确使用抗生素水平。教育公众提高医药知识水平,让他们认识到非处方使用抗生

作者单位:461200 河南省鄢陵县人民医院